

БЕКИТЕМ

Кыргыз Республикасынын
Саламаттык сактоо жана социалдык
өнүктүрүү министрлигинин алдындагы
Дары каражаттары жана медициналык
буюмдар департаментинин
директорунун орун басары
Мамбеталиева Ч. М.

«18» май 2021-ж.

**ДАРЫ КАРАЖАТЫН МЕДИЦИНАДА КОЛДОНУУ БОЮНЧА
НУСКАМА**

РИНАЛЕР

Препараттын соодадагы аталышы: Риналер.

Эл аралык патенттелбеген аталышы (ЭПА): Мометазон.

Дарынын түрү: мурун көңдөйүнө спрей.

Курамы: 1 грамм спрей төмөнкүлөрдү камтыйт:

Активдүү зат:

Мометазон фуруат моногидрат 0,5175 мг
(0,5000 мг Мометазон фуруат туура келет)

Көмөкчү заттар: дисперстик целлюлоза, глицерин, лимон кислотасынын моногидраты, натрий цитрат дигидрат, полисорбат 80, бензалконий хлорид (100%), фенилэтилдүү спирт, деионизирленген суу.

Сүрөттөмөсү: Ак түстөгү суулуу суспензия, чайкоодо бир түрдүү болот.

Фармадарылык тобу: Респиратордук системанын ооруларын дарылоо үчүн препараттар. Назальные препараты. Деконгестанттар жана жергиликтүү колдонуу үчүн мурун көңдөйүнө башка препараттар. Кортикостероиддер. Мометазон.

АТХ коду: R01AD09.

Фармакологиялык касиеттери

Фармакодинамикасы

Мометазон фуруат системалык натыйжалар пайда болбоочу дозаларда сезгенүүгө каршы таасири менен жергиликтүү глюкокортикостероид болуп саналат. Мометазон фуруаттын аллергияга каршы жана сезгенүүгө каршы таасири анын

аллергиялык реакциялардын медиаторлорунун бошонуусун басынтуу жөндөмдүүлүгү менен байланыштуу. Мометазон фуруат лейкотриендерди аллергиялык оорулары менен бейтаптардын лейкоциттеринен бошонуусун олуттуу токтотот.

Клеткалардын культурасында мометазон фуруат IL-1, IL-5, IL-6 жана TNF α синтезин ингибирлөөдө жана бошонуусунда жогорку натыйжалуу таасирди көрсөттү; мометазон фуруат, ошондой эле, лейкотриендердин продукциясынын активдүү ингибитору болуп саналат. Мындан тышкары, зат Th2-цитокиндердин, адамдын CD4⁺ Т-клеткаларынын ичинен IL-4 жана IL-5 продукциясынын активдүү ингибитору болуп эсептелет.

Сезондук аллергиялык ринит менен бейтаптарда Риналер препаратынын клиникалык натыйжалуулугу алгачкы дозаны колдонуудан кийин 12 сааттан соң пайда болот.

Фармакокинетикасы

Мурун көңдөйүнүн ичине колдонууда мометазон фуруаттын системалуу биожеткиликтүүлүгү <1% (аныктоо ыкмасынын сезимталдуулугунда 0.25 пг/мл) түзөт. Мометазон фуруаттын суспензиясы АИЖ абдан начар сиңирилет, жана мурунга чачыратуудан кийинки АИЖ өтүшү мүмкүн болгон анча көп эмес өлчөмү, өт жана заара менен бөлүнүп чыгуусуна чейин алгачкы активдүү зат алмашууга кабылат.

Колдонууга көрсөтмө

- чоңдордо жана 3 жаштан жогору балдарда сезондук же жылга созулган аллергиялык ринитти дарылоо;
- курч синусит же 12 жаштан улуу өспүрүмдөрдө жана чоңдордо (анын ичинде улгайгандарда) өнөкөт синуситтин өчүшүп кетүүсү – антибиотиктер менен дарылоодо көмөкчү дарылоо катары;
- 12 жаштан баштап бейтаптарда оор бактериялык инфекциянын белгилери жок жеңил жана орточо симптомдору бар курч риносинусит;
- чоңдордо жана 12 жаштан улуу өспүрүмдөрдө орто оор жана оор өтүп жаткан мезгилдүү аллергиялык ринитти **алдын-алуучу дарылоо** (чандоо сезону башталаардан 2-4 жума мурун сунушталат);
- мурун полиптерин жана ага байланыштуу болгон симптомдорду, анын ичинде мурундун бүтүшү жана жыт сезүүнүн жоголушу, 18 жаш курактан жогору бейтаптарда.

Каршы көрсөтмөлөр

- активдүү затка, көмөкчү курамдык заттарга жогорку сезимталдуулук;
 - мурундун былжыр челине байланыштуу дарыланбаган локалдык инфекциялардын болушу;
 - жакынкы арада өткөзүлгөн хирургиялык операция же мурундун жабыркашы (кортикостероиддер жаракаттын жай айыгышына алып келет);
 - бала курагы (сезондук жана жыл бою созулуучу аллергиялык ринит менен - 3 жылга чейин, курч гайморит же өнөкөт синуситтин күчөшү менен - 12 жашка чейин, полипоз менен - 18 жашка чейин) — туура келүүчү маалыматтардын жок болушуна байланыштуу.
- Этияттуулук менен: респиратордук жолдун кургак учур инфекциясы (активдүү же латенттик); дарыланбаган мите козу карныдык, бактериялык, системалык вирустук инфекция же Herpes simplex тарабынан козголгон көздөрдү жабыркатуучу инфекция, (өзгөчө учурларда, дарыгердин көрсөтмөсү боюнча, көрсөтүлгөн инфекцияларга

препаратты дайындоого болот); мурун көңдөйүнүн былжыр челинин катышуусу менен дарыланбаган жергиликтүү инфекциянын болушу.

Колдонуу жолу жана дозалар

Сезондук же жыл бою созулган аллергиялык ринит

Чоңдорго (анын ичинде улгайган курактагы бейтаптарга) жана 12 жаштан жогору балдарга препараттын сунуш кылынган дозасы күнүнө 1 жолу ар бир мурун кобулуна 2 чачыратуу (ар бири 50 мкг) түзөт (суткалык дозасы - 200 мкг). Колдоочу дарылоо үчүн дарылык натыйжага жеткенде, дозаны күнүнө 1 жолу ар бир мурун кобулуна 1 чачыратууга чейин азайтуу сунушталат (жалпы суткалык доза - 100 мкг). Эгерде препаратты сунуш кылынган дозада колдонуу менен оорунун белгилеринин деңгээлинин төмөндөшүнө жетише албасаңыз, анда суткалык дозаны максимумга чейин көбөйтүүгө болот: күнүнө 1 жолу ар бир мурун кобулуна 4 жолу чачыратуу (жалпы суткалык доза - 400 мкг). Оорунун симптомдорунун айкындуулугу төмөндөгөндөн кийин, дозасын азайтуу сунушталат.

3 жаштан 11 жашка чейинки балдар үчүн күнүнө 1 жолу ар бир мурун кобулуна 1 чачыратуу (50 мкг) сунушталат (жалпы суткалык доза - 100 мкг).

Кээ бир сезондук аллергиялык ринит менен бейтаптарда клиникалык натыйжанын башталышы дарылоо башталгандан кийинки алгачкы 12 саатта эле байкалышы мүмкүн, бирок 48 сааттан кийин гана толук натыйжалуу таасирге жетишүүгө болот. Ошондуктан толук клиникалык натыйжага жетишүү үчүн препаратты үзгүлтүксүз колдонуу маанилүү. Оору таржымалында аллергиялык риниттин орточо жана оор даражадагы симптомдору менен ооруган бейтаптар Риналер менен дарылоону гүлдөө мезгилинин күтүлүп жаткан башталышына бир нече күн калганда башташы керек.

Мурун полипозу

Чоңдорго (анын ичинде улгайган курактагы бейтаптарга) жана 18 жаштан жогору балдарга препараттын сунуш кылынган дозасы күнүнө 1 жолу ар бир мурун кобулуна 2 чачыратууну (50 мкг) түзөт (суткалык дозасы - 200 мкг). Эгерде препаратты сунушталган дозада 5-6 жума бою колдонуп, оорунун белгилеринин күчүнүн төмөндөшүнө жетише албасаңыз, анда күнүмдүк дозаны күнүнө 2 жолу ар бир мурун кобулуна 2 чачыратуудан көбөйтсө болот (жалпы суткалык доза - 400 мкг). Дозаны оорунун симптомдору натыйжалуу көзөмөлдөнгөн эң төмөнкү дозага ылайыкташтыруу керек. Эгерде күнүнө эки жолу кабыл алгандан кийин 5-6 жумадан кийин симптомдордун басандашы байкалбаса, анда дарылоонун альтернативдүү жолдору каралышы керек.

Колдонуу жолу

Препаратты биринчи жолу колдонуудан мурун, бөтөлкөнү жакшылап чайкоо жана дозалоочу учтукту болжол менен 10 басуу жасоо керек (бир тектүү спрей алынганга чейин), муну менен препаратты жеткирүү аткарылат, анда ар бир басылган сайын болжол менен 50 мкг мометазон (бир доза) камтыган 100 мг суспензияны чачыратуу жүрөт. Эгерде дозалоочу учтукту 14 күн аралыгында же андан көп убакыттан бери колдонулбаса, анда бир жолу чачыратмайынча, эки жолу басуу жолу менен дозалоочу учтукту кайрадан даярдаш керек. Флаконду ар бир колдонуунун алдында жакшылап чайкоо зарыл. Флаконду этикеткасында көрсөтүлгөн дозалардын санын колдонгондон кийин же биринчи колдонгондон кийин 2 айдан соң ыргытуу зарыл.

Кыйыр таасири

абдан тез-тез ($\geq 1/10$)

- мурундан кан агуу (мурундун полипозунда препаратты суткасына 2 жолу колдонууда).

тез-тез ($\geq 1/100$ до $< 1/10$)

- фарингит;

- жогорку дем алуу жолдорунун инфекциясы;

- баш ооруу;

- мурундан кан агуу;

- мурундун ачышуусу;

- мурундун былжырлуу чел кабыгынын дүүлүгүүсү жана жаралануусу;

- тамактын дүүлүгүүсү (мурундун полипозунда препаратты суткасына 2 жолу колдонууда).

белгисиз

- жогорку сезгичтик, анын ичинде анафилактикалык реакциялар, ангиодема, бронхоспазм жана демигүү;

- глаукома, көз ичиндеги жогорку басым, катаракта, бүдөмүк көрүү;

- мурун бөлүмүнүн перфорациясы;

- даам жана жыт сезүүнүн бузулуусу.

Балдар

Дем алуу системасы, көкүрөк клетка жана орто көңдөй тарабынан: мурундан кан агуу (6%), мурундун былжырлуу чел кабыгынын дүүлүгүүсү (2%), чүчкүрүү (2%).

Нерв системасы тарабынан: баш ооруу (3%).

Балдарда көрсөтүлгөн жагымсыз көрүнүштөрдүн пайда болуу жыштыгы плацебо колдонууда пайда болгон жыштык менен окшош болгон.

Божомолдонгон жагымсыз реакциялар тууралуу билдирүү

Дары препараттын каттоодон кийин кыйыр таасирлери жөнүндө маалыматтарды билдирүү препаратты колдонуудагы пайда жана тобокелдик ара катышына мониторинг жүргүзүү үчүн олуттуу мааниге ээ. Бардык медициналык кызматкерлер жана бейтаптар кайсы болбосун кыйыр реакциялар тууралуу медицинада колдонуу үчүн ушул нускаманын аягында келтирилген дарекке жана телефон номерлерине билдириши керек.

Ашыкча доза

Симптомдору: Кортикостероиддердин жогорку дозаларын ингаляциялоо же ичип кабыл алуу гипоталамус-гипофиз-бөйрөк үстүндөгү без системасын басышы мүмкүн. Мометазон фууроатынын төмөн (-0,1%) системалык биожеткиликтүүлүгүнөн улам, Риналердин ашыкча доза алуу аз ыктымалдуу (детерминациялоо ыкмасынын сезгичтиги 0,25 пг / мл), сунуш кылынган дозада препарат бейтаптын кийинки колдонулушу менен мониторинг жүргүзүүдөн башка чараларды талап кылбайт.

Дарылоо: симптомдоруна жараша дарылоо.

Башка дары каражаттары менен өз ара таасири

Мометазон фууроатын лоратадин менен лоратадинди бир мезгилде колдонуу лоратадиндин же анын негизги метаболитинин плазмалык концентрациясына эч кандай таасир тийгизген эмес, ошондой эле 50 пг / мл аныктоо ыкмасынын сезгичтиги менен кан плазмасында мометазон фууроат аныкталган жок. Бейтаптар айкалышкан дарылоонун жакшы

өткөрүшкөн.

Мометазон фуруатты СҮРЗА4 күчтүү ингибиторлору менен, кобицистат камтыган препараттарды кошкондо, бир убакытта коштоп колдонууда кортикостероиддердин бөлүнүп чыгуусунун жогорулоосуна, жана мындан улам, кортикостероиддердин системалуу кыйыр натыйжалуу таасирлеринин кооптуулугун потенциалдуу жогорулоосуна алып келиши мүмкүн. Препараттарды бир убакытта коштоп колдонуунун артыкчылыктары жана кортикостероиддердин системалуу кыйыр натыйжаларынын өнүгүүсүнүн потенциалдуу коркунучтары тууралуу маселени карап чыгуу зарыл.

Өзгөчө көрсөтмөлөр

Риналерди дем алуу жолдорунун кургак учуктун активдүү же жашыруун инфекциясы, дарыланбаган мите козу карындык, бактериялык же системалык вирустук инфекциясы же көздүн катышы бар жөнөкөй учук инфекциясы бар бейтаптарга этияттык менен же таптакыр колдонууга болбойт.

Кортикостероиддерди кабыл алып жатышкан бейтаптар иммундук реактивдүүлүктүн потенциалдуу төмөндөтүшүнө ээ болушу мүмкүн жана кээ бир жугуштуу оорулар менен (мисалы, чечек, кызылча) жабыркаган бейтаптар менен байланышкан учурда инфекциянын көбөйүү коркунучу жөнүндө эскертүү керек, ошондой эле мындай контакт болгондо дарыгерге кайрылуу керектигин эскертүү керек.

Мометазон фуруат менен 12 ай аралыгында дарылангандан кийин мурундун былжыр челинин атрофия белгилери байкалган жок; мындан тышкары, мометазон фуруаты мурундун былжыр челинин гистологиялык сүрөтүнүн калыбына келүүсүнө өбөлгө түзгөн. Кайсы болбосун башка узак мөөнөттүү дарылоо сыяктуу эле, Риналерди бир нече ай же андан көп убакыт бою колдонгон бейтаптар мурундун былжыр челиндеги өзгөрүүлөргө мезгил-мезгили менен текшерилип турушу керек. Мурундун же кекиртектин жергиликтүү мите козу карындык инфекциясы пайда болгон учурда, Риналер менен дарылоону токтотуу же атайын дарылоо жүргүзүү керек. Мурун жана кекиртектин былжыр челинин кыжырдануусу, узак убакытка чейин сакталып турушу, ошондой эле Риналер менен дарылоону токтотуунун көрсөткүчү болушу мүмкүн.

Мурун аралыгында перфорация учурунда препарат сунушталбайт.

Препараттын курамында бензалконий хлориди бар, ал мурундун былжыр челинин дүүлүгүүсүнө алып келиши мүмкүн.

Мурун көндөйүнө колдонулуучу кортикостероиддеринин системалык таасирлери, тактап айтканда узак мөөнөткө колдонууга арналган жогорку дозаларын колдонууда менен пайда болушу мүмкүн. Бул көрүнүштөр пероралдык кортикостероиддерди колдонууга караганда бир кыйла аз кездешет, ар кандай бейтаптарда жана ар кандай кортикостероиддерди кабыл алууда ар кандай болушу мүмкүн. Кортикостероиддердин системалык таасири Кушинг синдрому, кушингоиддик симптомдор, бөйрөк үстүндөгү бездин функциясын басынтуу, балдардагы жана өспүрүмдөрдөгү өсүштүн кармалуусу, катаракта, глаукома жана психологиялык же жүрүм-турумдук өзгөрүүлөр, анын ичинде психомотордук гиперреактивдүүлүк, уйкунун бузулушу, тынчсыздануу, депрессия же агрессия (айрыкча балдарда) түрүндө көрүнөт.

Мурун көндөйүнүн ичине колдонулуучу кортикостероиддерди колдонгондон кийин көз ичиндеги басымдын жогорулагандыгы жөнүндө айрым маалыматтар бар.

Системалуу жана жергиликтүү таасир берүүчү кортикостероиддерди колдонууда (анын

ичинде мурун көңдөйүнүн ичине, ингаляциялык жана көз ичине куюу) көрүүдө бузулуулар пайда болушу мүмкүн. Эгерде мындай симптомдор пайда болсо, бүдөмүк көрүү же көрүү тарабынан башка бузулуулар сыяктуу, бейтапка катаракта, глаукома же борбордук сероздук хориоретинопатияны камтышы мүмкүн болгон, алар тууралуу системалуу жана жергиликтүү таасир берүүчү кортикостероиддерди колдонуудан кийин билдирилген, көрүүнүн бузулуусунун себебин аныктоо үчүн офтальмологдун текшерүүсүнөн өтүүсү керек.

Системалуу таасир берүүчү кортикостероиддер менен узак мөөнөттүн аралыгында дарылануудан өтүп Риналер препараты менен дарылоого которулуп жаткан бейтапка дарыгер кылдат көзөмөл жүргүзүшү керек.

Системалуу таасир берүүчү кортикостероиддерди мындай бейтаптарда колдонууну токтотуу бир канча айдын аралыгында бөйрөк үстүндөгү бездердин кабыгынын функциясынын алсыздыгына алып келиши мүмкүн, бул нерсе системалуу кортикостероиддер менен дарылоону калыбына келтирүүнү жана башка туура келүүчү дарылоону талап кылышы мүмкүн. Системалуу таасир берүүчү кортикостероиддер менен дарылоодон Риналер препараты менен дарылоого өтүү мезгилинде айрым бейтаптарда, мурун симптомдорунун жеңилдөөсү менен бир катар, кортикостероиддердин токтотуу симптомдору пайда болушу мүмкүн (мисалы, муундарда жана/же булчуңдарда ооруу, чарчоо сезими жана депрессия). Дарылоону которуу системалуу таасир берүүчү кортикостероиддер менен дарылоо менен жашырылган жана мурда эле өнүккөн аллергиялык ооруларды (аллергиялык конъюнктивит, экзема жана башкалар) дагы аныкташы ыктымал.

Сунушталгандан ашып түшүүчү дозалар менен дарылоо, бөйрөк үстүндөгү бездердин функциясын клиникалык айкын басынтуусуна алып келиши мүмкүн. Жогорку дозаларды колдонуп дарылоого зарыл болгон көрсөткүчтөр бар болгон учурда, өзгөчө стресс же пландалган хирургиялык кийлигишүү мезгилдеринде, башка системалуу кортикостероиддер менен айкалыштыруу мүмкүнчүлүгүн карап чыгуу зарыл.

Мометазон фууроаттын бир тараптуу полиптерди, кистоздук фиброз менен байланыштуу полиптерди, же мурун көңдөйүн толугу менен толтуруучу полиптерди дарылоодо коопсуздугу жана натыйжалуулугу жеткиликтүү изилденген эмес.

Адаттагыдан башкача же өзгөргөн сырткы көрүнүшү менен бир тараптуу полип бар болгон учурда, өзгөчө жаралануу жана кан агуу бар болсо, диагностиканын кошумча ыкмаларын өткөрүү зарыл.

Препаратты кичүү курактагы балдарда колдонуу чоңдордун көзөмөлү алдында жүргүзүлүшү керек.

Мурун көңдөйүнө колдонулчу кортикостероиддер менен узак убакыттын аралыгында дарылоо алып жаткан балдардын боюн үзгүлтүксүз өлчөп туруу сунушталат. Бойдун өсүшүнүн жайлануусун аныктаган учурда мурун көңдөйүнө колдонулчу кортикостероиддердин дозасын эң төмөнкү дозасына чейин төмөндөтүү мүмкүндүгүн карап чыгуу керек, анда симптомдорду натыйжалуу көзөмөлдөө сакталат. Мындан тышкары, бейтапты педиатрга кеңеш алуу үчүн багыттоо зарыл.

Риналер препараты менен дарылоо көптөгөн бейтаптарда оорунун мурундагы симптомдорун көзөмөлдөөнү камсыздайт, бирок, оорунун офтальмологиялык симптомдорун жеңилдетүү үчүн кошумча дарылоону колдонуу мүмкүнчүлүгүн карап чыгуу керек.

Көмөкчү зат

1 г Риналер препараты 0,2 мг туура келген бензалконий хлоридин камтыйт. Бул көлөм колко карышуусун козгобойт.

Кош бойлуулукта жана бала эмизүү мезгилинде колдонуу

Препаратты кош бойлуу аялдардын колдонуусу боюнча изилдөөлөр жүргүзүлгөн эмес. Бирок, башка мурун көндөйүнүн ичине колдонулуучу башка кортикостероиддер сыяктуу эле, эгерде күтүлүүчү пайда энеге, түйүлдүккө же балага болгон коркунучун актаса Риналер кош бойлуу аялдарда колдонулат. Кош бойлуу кезинде энелери кортикостероиддерди колдонгон ымыркайлар бөйрөк үстүндөгү бездердин мүмкүн болгон гипофункциясы предметине кылдат текшерилиши керек.

Бала эмизүү

Мометазон фуоратынын эмчек сүтүнө бөлүнүп чыкканы белгисиз. Пайда жана тобокелдиктин ара катышын эске алуу менен бала эмизүүнү токтотуу же дарылоону үзгүлтүккө учуратуу керек.

Автомобил жана татаал механизмдерди башкаруу жөндөмдүүлүгүнө таасир берүүсү

Авто унаа жана потенциалдуу кооптуу механизмдерди башкаруу жөндөмдүүлүгүнө препараттын таасир берүүсү тууралуу маалыматтар жок.

Чыгаруу формасы:

18 г препарат ак түстөгү жогорку тыгыздыктагы полиэтиленден чачыраткычы бар жана полипропиленден коргоочу ак капкакчасы менен флакондо.

1 флакон медицинада колдонуу боюнча нускамасы менен бирге картон кутуга салынат.

Сактоо шарты:

Кургак, жарыктан корголгон жерде, 25°C дан жогору эмес аба табында сактоо керек.

Балдар жетпеген жерде сактоо зарыл.

Тондурууга болбойт.

Жарактуулук мөөнөтү

2 жыл. Жарактуулук мөөнөтү аяктагандан кийин колдонууга болбойт.

Дарыканалардан берүү шарты

Рецепт боюнча

Соода маркасынын жана

каттоо күбөлүгүнүн кармоочусу:

BELINDA LABORATORIES LLP

Astra House, Arklow Road,

London, England SE14 6EB, UK (Улуу Британия)

Өндүрүүчү:

SANTA FARMA İLAÇ SAN. A.Ş.

Kocaeli-Gebze V (Chemicals) Specialization

Organized Industry Zone, Erol Kiresepi Cad.,
No: 8, Dilovasi, Kocaeli, Turkey (Түркия)

**Кыргыз Республикасынын аймагында өндүрүмдүн (товардын) сапаты боюнча арыз-
доолорду кабыл алуучу уюмдун дареги:**

«Aman Pharm» ЖЧК (Аман Фарм), Кыргызстан Республикасы, Бишкек шаары,
Шоорукова көч. 36.

Тел: (0312) 560466, E-mail: aman.pharm12@gmail.com